

Dossiê de revisão médica — módulo AVC

Nove pacotes de revisão de docs/avc/revisao/ (lista do README.md), reunidos sem alteração de conteúdo. Repositório em 034db66, gerado em 2026-09-14.

Nada aqui é decisão. Cada pacote traz pergunta clínica, população, cenário, comportamento atual do app, critério proposto (opções, sem escolha), exceções, conduta diante de "não sei", fonte com página e trechos literais curtos, e o campo "Decisão humana".

#	quem decide	pacote	impacto
1	[responsável médico do projeto]	AC-15 · Suspeita de HSA retendo a reperfusão isquêmica	retém ou libera reperfusão diante de possível hemorragia
2	[responsável médico do projeto]	AC-06 · Arredondamento da dose do trombolítico	número que vai na veia
3	[responsável médico do projeto]	D-139 · Interpretação 2 · Varfarina ou heparina: quais exames aguardar	liberação da trombólise em anticoagulado
4	[responsável médico do projeto]	D-139 · Interpretação 1 · Juízo sobre coagulação não perguntado	trombólise sem coagulograma
5	[responsável médico do projeto]	D-139 · Interpretação 3 · Julgamento individual pendente	liberação com risco hemorrágico individual
6	[responsável médico do projeto]	D-139 · Interpretação 4 · Déficit incapacitante só na rota padrão	elegibilidade na janela estendida
7	[responsável médico do projeto]	AC-03 (resíduo) · Janela de puerpério	portão de população (gestação e puerpério)
8	[autor]	AC-13 · Estados da ação (4 × 8)	modelo de registro da ação, sem conteúdo clínico
9	[autor]	AC-14 · Temperatura no caminho isquêmico	já decidido pelo autor (D-PEND-18)

Critérios desta reunião (classificação do agente, a confirmar pelo autor)

- Ordem por impacto clínico:** primeiro o que retém ou libera reperfusão diante de risco hemorrágico e a dose; depois elegibilidade; depois o portão de população; por último o modelo de registro e o pacote já decidido.
- Quem decide:** [responsável médico do projeto] quando a pergunta é conteúdo clínico de elegibilidade, segurança ou dose da reperfusão — validação clínica final pelo responsável médico do projeto, com rastreabilidade explícita para literatura primária e documentação oficial. Testes automatizados não substituem essa revisão clínica. [autor] quando é estrutura de registro do app ou já tem decisão do autor.
- AC-14 já está decidido** (D-PEND-18, Sandro Dainez, 13/09/2026): o campo "Decisão humana" desse pacote mantém a decisão registrada e não foi apagado.
- Atualizações posteriores** (seções 9A, 10A e 12 de alguns pacotes) fazem parte dos arquivos e estão incluídas. Pacotes relacionados que não seguem este formato ficaram fora: hsa-resolucao.md, bula-x-diretriz.md, pcdt-brasil.md, errata-2026.md, hemorragia.md, plano-48h.md.
- Pacotes datados:** os textos são de 2026-09-13, com as atualizações que cada arquivo recebeu. Decisões posteriores registradas em docs/decisoes.md não foram reescritas dentro dos pacotes; onde existem, estão ditas numa faixa no topo da página (AC-15, AC-06, AC-03r).
- Um pacote por página:** cada pacote começa numa página nova e ocupa as páginas que o texto exige.
- Limites de fonte** (do README): a Table 8 da AHA/ASA 2026 é imagem no PDF; os trechos literais são curtos e o texto integral está no PDF, na página indicada.

docs/avc/revisao/AC-15-hsa.md

Registro fora do pacote: a retenção por suspeita clínica de HSA foi decidida pela D-PEND-23 (docs/decisoes.md, 2026-09-13; fonte nominal de bula na 18ª rodada) e o pacote não foi carimbado (docs/status.md, fila, linha 16). A pergunta sobre o que resolve a suspeita segue aberta em hsa-resolucao.md.

AC-15 · Suspeita de HSA retendo a reperfusão isquêmica

Estado: aguardando decisão humana · **Criado em:** 2026-09-13 **Origem:** docs/avc/matriz-regras.md:220-226 (RQ-REG-HSA) · docs/avc/auditoria-vs-spec.md:46 (AC-15)

1 · Pergunta clínica

Num adulto candidato à reperfusão isquêmica cuja imagem não mostra hemorragia, a **suspeita clínica** de hemorragia subaracnóidea deve reter a **execução** da trombólise e da trombectomia? E HSA **vista na imagem** deve abrir um caminho próprio, distinto da hemorragia intracerebral?

2 · População

Adulto (portão AC-03) candidato a IVT ou EVT.

3 · Cenário

- O médico registra a suspeita clínica de HSA.
- A imagem registrada é "Sem hemorragia intracraniana identificada", ou ainda não há resultado.

4 · Comportamento atual do código

o quê	onde
Campo <code>suspeita_hsa</code> , com opções Sim / Não / Incerto e fonte: "F-16"	avc/conteudo/superficie-c.ts:864
Nota do próprio campo: a fonte "não define conduta para esta suspeita"	avc/conteudo/superficie-c.ts:894
Leitura da suspeita como verdadeira	avc/nucleo/derivacoes-c.ts:546
"Incerto" vira resposta sem retenção	avc/nucleo/derivacoes-c.ts:609
<code>retencaoDiagnostica</code> : com "Sim", fica retida	avc/nucleo/derivacoes-c.ts:704
Portão da IVT lê a retenção → <code>saida_diagnostica_pendente</code> , abaixo de segurança, COR 3 e não sustentada	avc/nucleo/portao-ivt.ts:291
Veredito da EVT carrega a mesma retenção	avc/nucleo/veredito-da-trombectomia.ts (retencaoDiagnostica)
Prova: "Incerto" não retém	scripts/prova-avc-criticos.cjs:772

HSA confirmada na imagem:

- O resultado da TC só tem duas opções (`OPCOES_RESULTADO_TC`, em `superficie-c.ts`).
- HSA vista na imagem entra como "Hemorragia intracraniana identificada": cai na barreira de classe da F-16 e no destino de hemorragia intracerebral. **Não existe regra própria de HSA confirmada.**

Cobertura: nenhum e2e verifica a retenção na tela de Reperfusão. A busca por `saida_diagnostica` e `suspeita_hsa` fora de `e2e/avc-superficie-c.spec.ts` retorna 0.

5 · Critério proposto — opções para decisão, sem escolha

opção	comportamento
A · atual	Suspeita "Sim" retém a execução de IVT e EVT até ser respondida "Não" ou corrigida; "Incerto" não retém e abre pendência nomeada.
B	A suspeita é registrada e mostrada, mas não retém a execução; a exclusão de hemorragia continua sendo só da imagem.
C	Opção A, mais uma saída própria para HSA vista na imagem , com conteúdo a transcrever da fonte de HSA.

6 · Exceções já vigentes

- Hemorragia identificada na imagem retém a classe pela F-16, qualquer que seja a opção.
- Bloqueio de segurança prevalece sobre a retenção diagnóstica (ordem em `portao-ivt.ts`).

7 · Dados necessários

- Registro da suspeita clínica (existe).
- Resultado da imagem (existe, sem distinguir HSA).
- Opção C: um campo de resultado de imagem que distinga HSA (não existe).

8 · Conduta diante de "não sei"

Hoje "Incerto" é gravado como `nao_sei`, não retém e abre a pendência "Registrar a conclusão sobre a suspeita". A decisão deve dizer se isso se mantém.

9 · Fonte primária

AHA/ASA 2026, §3.2 *Initial, Vascular, and Multimodal Imaging Approaches*, rec. 1 · COR 1 · LOE A.

- Localização: PDF p. 26 = página impressa **e341**.
- Transcrição: `protocols/fontes-verbatim/aha-asa-2026-avc-isquemico.md:2204-2207`.
- Trecho literal (conferido no PDF): "*exclude intracranial hemorrhage before initiating reperfusion interventions*".

AHA/ASA 2023, HSA aneurismática.

- A busca no PDF inteiro por `thromboly|alteplase|tenecteplase|reperfusion|thrombectomy|acute ischemic stroke` não encontrou recomendação sobre suspeita de HSA em candidato à reperusão isquêmica.
- As duas ocorrências (PDF p. 35 e 38) tratam de outros assuntos.
- A §4 (diagnóstico) **não foi transcrita** (`aha-asa-2023-hsa.md:309-311`).

 **A fonte não confirma o comportamento atual.**

- Ela manda excluir hemorragia **por imagem** antes da reperusão.
- Ela **não** diz nada sobre reter a execução por suspeita clínica com imagem sem hemorragia.
- A própria nota do campo e `auditoria/ESPECIFICACAO-AVC.md:512-513` reconhecem isso.

10 · Separação das camadas

camada	conteúdo
Recomendação da diretriz	Imagem de emergência para excluir hemorragia intracraniana antes de iniciar reperusão (§3.2 rec. 1, COR 1, LOE A).
Adaptação local	A suspeita clínica de HSA retém a execução da IVT e da EVT. É decisão do autor de 2026-09-12 (red-team O3), registrada em <code>auditoria/ESPECIFICACAO-AVC.md:509-519</code> , sem nome e sem versão. O destino único vem do PD-21 (<code>auditoria/DECISOES-DE-PRODUTO.md:958</code>).
Escolha de interface	"Incerto" não retém e vira pendência nomeada; o botão "Resolver" leva ao campo; a retenção aparece como "Saída diagnóstica armada".

11 · Decisão humana

Decisão humana: ____ (nome, versão, data)

docs/avc/revisao/AC-06-dose-trombolitico.md

Registro fora do pacote: a dose foi decidida pelas D-PEND-22 (tenecteplase exata) e D-PEND-25 (alteplase exata) em docs/decisoes.md (2026-09-13), e o pacote não foi carimbado (docs/status.md, fila, linha 16). A duração do bolus (bula × diretriz) segue aberta em bula-x-diretriz.md.

AC-06 · Arredondamento da dose do trombolítico

Estado: aguardando decisão humana · Criado em: 2026-09-13 Origem: docs/avc/auditoria-vs-spec.md:37 (AC-06) · docs/status.md (D-PEND-12)

1 · Pergunta clínica

- Como a dose calculada por peso deve ser arredondada?
- **Alteplase:** mg inteiro, décimo de mg, ou sem arredondamento?
 - **Tenecteplase:** mg/kg arredondado, ou a **tabela por faixa de peso** da fonte?

2 · População

Adulto validado pelo portão de população (AC-03), com peso e origem do peso registrados.

3 · Cenário

O médico escolhe o agente na tela de Reperfusão, e o app mostra "Cálculo de dose — não é administração".

4 · Comportamento atual do código

o quê	onde
Constantes: alteplase 0,9 mg/kg, máx. 90; tenecteplase 0,25 mg/kg, máx. 25	avc/conteudo/superficie-f.ts:1191-1192
Cálculo: <code>Math.min(Math.round(pesoKg * d.mgPorKg), d.maximoMg) — mg</code> inteiro, teto aplicado depois	avc/nucleo/derivacoes-f.ts:254
Peso: inteiro de 30 a 200 kg	avc/conteudo/paciente.ts:194
Origem do peso: informado / estimado / "Não sei"	avc/conteudo/paciente.ts:244
Prova: 70 kg → alteplase 63 mg	scripts/prova-avc-superficie-f.cjs:227

Tenecteplase, código × Table 7.

- A coluna "código" é aritmética sobre a linha 254; só 70 kg é confirmado por prova.
- `Math.round` arredonda .5 para cima.

peso	código	Table 7 (faixa)
50 kg	13 mg	15 mg
60 kg	15 mg	17,5 mg
69 kg	17 mg	17,5 mg
70 kg	18 mg	20 mg
80 kg	20 mg	22,5 mg
90 kg	23 mg	25 mg

⚠ Comentário e commit contradizem a transcrição.

- O comentário em `derivacoes-f.ts:242-252` e o commit `6f230f1` dizem que a Table 7 dá "só mg/kg e o teto".
- A transcrição e o PDF trazem uma **tabela por faixa de peso** para a tenecteplase.

5 · Critério proposto — opções para decisão, sem escolha

opção	alteplase	tenecteplase
A · atual	mg inteiro, teto depois	mg inteiro, teto depois
B	mg inteiro, teto depois	faixa de peso da Table 7 (dose e volume)
C	sem arredondamento, com casas definidas por decisão	faixa de peso da Table 7
D	a definir pela bula brasileira, quando o PDF for aberto	idem

6 · Exceções

- **Nota da Table 7 para < 50 kg:** com peso exato conhecido, admite faixa de 1 kg.
- **Peso estimado:** a mesma nota diz que a faixa de 1 kg não é necessariamente mais segura que a de 10 kg.
- **Peso fora de 30–200 kg:** não é registrável hoje.

7 · Dados necessários

- Peso e origem do peso (existem).
- Opção B ou C: volume em mL da faixa (não existe no app).
- Opção D: PDF da bula brasileira (**não disponível**; ver §9).

8 · Conduta diante de "não sei"

Hoje, peso ausente ou origem "Não sei" → **sem dose**, e o app não estima peso (`superficie-f.tsx`, mensagem "O app não estima peso"). A decisão deve dizer se isso se mantém.

9 · Fonte primária

AHA/ASA 2026, Table 7 Treatment of AIS in Adults, PDF p. 43 = página impressa e358.

- Tabela operacional, sem COR/LOE.
- Transcrição: `protocols/fontes-verbatim/aha-asa-2026-avc-isquemico.md:1591-1612`.
- Trechos literais conferidos no PDF:
 - "Infuse 0.9 mg/kg (maximum dose 90 mg) over 60 min"
 - "Push 0.25 mg/kg (up to maximum 25 mg) based on patient body weight"
 - Linhas da tabela por faixa: <60 kg 15 mg · 60 kg to <70 kg 17.5 mg · 70 kg to <80 kg 20 mg · 80 kg to <90 kg 22.5 mg · ≥90 kg 25 mg
 - Nota: "dosing per 1-kg band may be used" (para < 50 kg com peso exato conhecido)

AHA/ASA 2026, §4.6.2 rec. 1 · COR 1 · LOE A. Transcrição :1557–1562; dose por kg e máximo, sem arredondamento.

Bulas brasileiras (`protocols/fontes-verbatim/bulas-br-tromboliticos.md`):

- **Actilyse:** transcrição **parcial**; a posologia do AVC está em :117–120, sem página e sem regra de arredondamento.
- **Metalyse 25 mg (AVC):** bula **não obtida** (:179).
- **PDF de nenhuma das duas** está no repositório ou no aparelho. A fonte candidata **não foi aberta**.
- ⚠ **Confronto com o código:**
 - **Alteplase:** a fonte **não fala** de arredondamento. O mg inteiro é adaptação local.
 - **Tenecteplase:** a fonte **contradiz** o código. A Table 7 tem a tabela por faixa de peso, e o app calcula mg/kg arredondado, com valor abaixo da faixa em cinco dos seis pesos da tabela acima.

9A · Ampliação de 2026-09-13 — pedido do autor (AC-43), sem código

9A.1 · Recomendação textual × Table 7

onde	classe e nível	página	trecho literal (conferido no PDF)
§4.6.2 Choice of Thrombolytic Agent, rec. 1	COR 1 · LOE A	PDF p. 42 = e357	"tenecteplase at a dose of 0.25 mg/kg body weight (max 25 mg)"
Table 7 Treatment of AIS in Adults	tabela operacional, sem COR/LOE	PDF p. 43 = e358	"Push 0.25 mg/kg (up to maximum 25 mg) based on patient body weight", seguida da tabela por faixa de peso (§9)

- **Transcrição:** a rec. 1 está em `protocols/fontes-verbatim/aha-asa-2026-avc-isquemico.md:1557-1562`; a Table 7, em :1591–1612.
- ⚠ A recomendação textual dá **mg/kg e máximo**. A Table 7 dá a mesma posologia e a tabela de administração por faixa de peso, com volume. **Nenhuma das duas fala em arredondar para mg inteiro**.

9A.2 · Cálculo comparativo — tenecteplase, três condutas

- **Exata:** 0,25 mg/kg, com teto de 25 mg, sem arredondamento.
- **Faixa:** a tabela da Table 7.
- **Inteiro atual:** o código de hoje, `Math.min(Math.round(peso × 0,25), 25)` em `avc/nucleo/derivacoes-f.ts:254`.
- **Volume:** a 5 mg/mL, como pedido. As linhas da Table 7 são coerentes com 5 mg/mL (15 mg · 3 mL ... 25 mg · 5 mL); a concentração após reconstituição **não foi conferida em bula** (§9A.3).
- **Método:** conta aritmética feita para este pacote, **não executada na tela**. Só 70 kg (inteiro, 18 mg) tem prova no código.

peso	exata	faixa (Table 7)	inteiro atual
50 kg	12,5 mg · 2,5 mL	15 mg · 3 mL	13 mg · 2,6 mL
60 kg	15 mg · 3 mL	17,5 mg · 3,5 mL	15 mg · 3 mL
70 kg	17,5 mg · 3,5 mL	20 mg · 4 mL	18 mg · 3,6 mL
80 kg	20 mg · 4 mL	22,5 mg · 4,5 mL	20 mg · 4 mL
90 kg	22,5 mg · 4,5 mL	25 mg · 5 mL	23 mg · 4,6 mL
100 kg	25 mg · 5 mL	25 mg · 5 mL	25 mg · 5 mL

Leitura sem decisão:

- **50, 70 e 90 kg:** as três condutas dão valores diferentes.
 - **60 e 80 kg:** a exata coincide com o inteiro atual; a faixa dá 2,5 mg a mais.
 - **100 kg:** as três dão 25 mg.
 - **Faixa × exata:** para pesos nestes pontos, a faixa nunca fica abaixo da exata.
 - **Inteiro atual × faixa:** o inteiro atual fica abaixo da faixa em 50, 60, 70, 80 e 90 kg.
- ⚠ **A nota da Table 7 para < 50 kg** (faixa de 1 kg com peso exato conhecido) não se aplica aos pesos desta tabela.

9A.3 · Situação regulatória no Brasil — a preencher

Situação regulatória no Brasil: ____ (quem conferiu, data, documento)

O que precisa ser conferido na ANVISA:

- **Registro:** registro vigente de tenecteplase (Metalyse®) no Brasil, com número e titular.
- **Indicação:** a indicação **AVC isquêmico agudo** consta do registro, ou só infarto agudo do miocárdio?
- **Apresentação:** existe a apresentação de 25 mg registrada e comercializada no Brasil?
- **Categoria:** categoria de venda e restrição de uso.

O que precisa ser conferido na bula profissional:

- **Versão:** versão e data da bula vigente para a apresentação usada no AVC.
- **Posologia do AVC:** mg/kg e máximo, e se traz tabela por faixa de peso para AVC (a bula de 40/50 mg traz faixas **para infarto**, que 🚫 não se usam no AVC: `bulas-br-tromboliticos.md:163-164`).
- **Preparo:** diluente, volume de reconstituição e **concentração final em mg/mL**, que confirma ou não os 5 mg/mL da §9A.2.
- **Graduação:** graduação da seringa e se a administração é por volume da faixa.
- **Estabilidade:** estabilidade depois de reconstituído.

Estado das fontes hoje:

- A bula de Metalyse 25 mg para AVC **não foi obtida** (`bulas-br-tromboliticos.md:179`).
- Nenhum PDF de bula está no repositório nem no aparelho.
- Acesso automatizado ao portal da ANVISA 🚫 não foi tentado.

10 · Separação das camadas

camada	conteúdo
Recomendação da diretriz	0,9 mg/kg (máx. 90 mg) e 0,25 mg/kg (máx. 25 mg) — §4.6.2 rec. 1. Table 7 operacional: bolus de 10% para a alteplase; faixas de peso para a tenecteplase.
Adaptação local	Arredondar para mg inteiro com teto depois. Frase do autor em 2026-09-12, registrada só na mensagem do commit <code>6f230f1</code> , sem nome nem versão formal.
Escolha de interface	Peso inteiro; dose mostrada como "cálculo, não administração"; origem do peso ao lado da dose; sem dose quando o peso é desconhecido.

11 · Achado registrado junto

- **AC-43 · alta · clínico.** A dose da tenecteplase não segue a tabela por faixa de peso da Table 7.
- A 70 kg o app mostra 18 mg; a faixa da fonte dá 20 mg.
- **Não corrigido:** exige decisão clínica.

12 · Decisão humana

Decisão humana: ____ (nome, versão, data)

D-139 · Interpretação 2 · Varfarina ou heparina: quais exames aguardar

Estado: aguardando decisão humana · **Criado em:** 2026-09-13 **Origem:** auditoria/DIVIDAS-CONHECIDAS.md:5765-5767 · docs/avc/auditoria-vs-spec.md:282 · commit 397bca3

1 · Pergunta clínica

Em quem usa varfarina ou heparina, quais resultados de coagulação precisam estar registrados antes da trombólise?

2 · População

Candidato à IVT com varfarina (ou outro antagonista da vitamina K), heparina ou heparina de baixo peso molecular registrada.

3 · Cenário

O paciente usa varfarina ou heparina, e algum exame de coagulação ainda não chegou.

4 · Comportamento atual do código

o quê	onde
Uso de varfarina ou heparina lido do campo de anticoagulante	avc/nucleo/derivacoes-d.ts:795
Exames exigidos: ["inr", "aptt", "tp"]	avc/nucleo/derivacoes-d.ts:801
Qualquer um dos três sem registro → impede_ate_resultado → portão resultado_pendente	avc/nucleo/derivacoes-d.ts:857

- Plaquetas não entram nesta lista.
- **Por leitura, não executado:** "Não sei" no anticoagulante não é tratado como possível varfarina.
- **⚠ Achado por leitura, a verificar por execução:**
 - Situação: varfarina registrada, INR, PT e aPTT registrados, plaquetas sem registro e juízo "não".
 - Resultado provável: o texto mostrado seria "Sem motivo para suspeitar; sem varfarina ou heparina registradas" (derivacoes-d.ts:887), com varfarina registrada.

5 · Critério proposto — opções para decisão, sem escolha

opção	exames a aguardar
A · atual	INR e PT e aPTT
B	Por agente, com o mapa definido por decisão humana
C	Um só exame de coagulação qualquer

6 · Exceções

- Valor que cruza o corte da fonte vira impedimento (derivacoes-d.ts, cortes da Table 8).
- A frase da fonte fala em **uso recente**; o campo diz **em uso**.

7 · Dados necessários

- Agente e horário da última dose (o horário existe só para DOAC).
- INR, PT e aPTT (existem).

8 · Conduta diante de "não sei"

"Não sei" no anticoagulante segue para o juízo da interpretação 1. A decisão deve dizer se "não sei se usa varfarina" basta.

9 · Fonte primária

AHA/ASA 2026, Table 8, faixa absoluta, p. e367.

- Tabela sem COR/LOE.

- ⚠️ A tabela é **imagem** no PDF; as frases foram conferidas **só na transcrição** (aha-asa-2026-avc-isquemico.md:1819-1826, leitura visual).

Trechos:

- "In patients without recent use of warfarin or heparin"
- "should be discontinued if INR >1.7, PT, or PTT is abnormal"

⚠️ **A fonte é ambígua quanto à regra do código.**

- A frase nomeia INR, PT e PTT **na cláusula de suspensão** de quem **não** usa varfarina ou heparina.
- Ela **não** define "coagulation test results", **não** diz que os três são exigidos e **não** diz o que fazer com quem usa esses agentes.
- Diferenças de termo: a fonte escreve "PTT", o código "aptt"; a fonte diz "heparin", a opção do app inclui heparina de baixo peso molecular.
- A transcrição registra (:1813-1815) que a Table 8 não tem célula própria para varfarina nem heparina.

10 · Separação das camadas

camada	conteúdo
Recomendação da diretriz	Quem não usa varfarina ou heparina pode iniciar antes dos resultados, suspendendo se INR > 1,7 ou PT/PTT alterado.
Adaptação local	Quem usa aguarda INR, PT e aPTT. É interpretação sem registro humano (auditoria-vs-spec.md:282). A leitura da opção heparina é decisão do autor (auditoria/PLANO-CORRECAO-AVC-CRITICOS.md:490).
Escolha de interface	Pendência "Exames de coagulação", com o que falta registrar.

10A · Atualização da 4ª rodada (2026-09-13)

- AC-46 · reproduzido e corrigido** em 62856f4 : com varfarina ou heparina registradas, a condição resolutiva deixou de dizer "sem varfarina ou heparina registradas". A pergunta clínica deste pacote continua **sem decisão**.

11 · Decisão humana

Decisão humana: ____ (nome, versão, data)

D-139 · Interpretação 1 · Juízo sobre coagulação não perguntado

Estado: aguardando decisão humana · Criado em: 2026-09-13 Origem: auditoria/DIVIDAS-CONHECIDAS.md:5761-5764 · docs/status.md (D-PEND-11) · commit 397bca3

1 · Pergunta clínica

A trombólise pode seguir sem coagulograma quando **ninguém respondeu** se há motivo para suspeitar de alteração da coagulação?

2 · População

Candidato à IVT com pelo menos um dos exames de corte (INR, aPTT, PT, plaquetas) sem registro.

3 · Cenário

Os exames não chegaram, e a pergunta "Há razão para suspeitar de coagulação alterada" está sem resposta, ou respondida.

4 · Comportamento atual do código

resposta do juízo	efeito	onde
Sim	impede_ate_resultado	avc/nucleo/derivacoes-d.ts:869
Não, sem varfarina ou heparina	condicao_resolutiva: pode iniciar antes do resultado e suspender se vier alterado	avc/nucleo/derivacoes-d.ts:881
Incerto	impede_ate_resultado	avc/nucleo/derivacoes-d.ts:893
Não perguntado	aguarda_juizo → portão informacao_incompleta, nomeando a pergunta	avc/nucleo/derivacoes-d.ts:905 · avc/nucleo/portao-ivt.ts:502

- **Prova do ramo "não perguntado":** scripts/prova-avc-criticos.cjs:392.
- **Por leitura:** o ramo não lê janela de tempo nem rota.
- **Cobertura:** nenhuma asserção isola "Incerto", e nenhum e2e verifica o título causado só pelo juízo não perguntado.

5 · Critério proposto — opções para decisão, sem escolha

opção	"não perguntado"	"incerto"
A · atual	informacao_incompleta (pergunta nomeada)	aguarda resultado
B	resultado_pendente (aguarda o exame)	aguarda resultado
C	condicao_resolutiva (como "não")	aguarda resultado

6 · Exceções

- Varfarina ou heparina em uso: aguarda resultado, qualquer que seja o juízo (interpretação 2).
- Os quatro cortes registrados: a pergunta nem é feita.

7 · Dados necessários

- Resposta ao juízo (existe).
- Janela de tempo, se a decisão restringir à população escrita da rec. 10 ("within 4.5 hours"). Hoje não é lida neste ramo.

8 · Conduta diante de "não sei"

"Incerto" → aguarda resultado (derivacoes-d.ts:893). É interpretação, e a decisão deve cobri-la.

9 · Fonte primária

AHA/ASA 2026, §4.6.1 rec. 10 · COR 2a · LOE B-NR.

- Localização: PDF p. 38 = página impressa e353.
- ⚠ A transcrição registra "p. e354" (aha-asa-2026-avc-isquemico.md:1846-1850); o texto extraído do PDF está na p. e353.
- Trecho literal (conferido no PDF): "if there is no reason to suspect an abnormal result".
- A população escrita da recomendação é "within 4.5 hours of last known well and eligible for IVT".

AHA/ASA 2026, Table 8, faixa absoluta, p. e367.

- ⚠ A tabela é **imagem** no PDF; a frase foi conferida **só na transcrição** (:1823–1826 , leitura visual).
- Trecho: "*can be initiated before availability of coagulation test results*".

⚠ **A fonte confirma só em parte.**

- O ramo "não" é sustentado.
- A fonte **não diz** o que fazer quando o juízo não foi feito, nem quando é incerto.

10 · Separação das camadas

camada	conteúdo
Recomendação da diretriz	Não atrasar a IVT esperando exames se não houver razão para suspeitar de resultado alterado (rec. 10). Iniciar antes do resultado em quem não usa varfarina ou heparina e suspender se vier alterado (Table 8).
Adaptação local	Juízo não perguntado ≠ negativo; "incerto" aguarda resultado. Decisão do autor para a HR-3 (auditoria/PLANO-CORRECAO-AVC-CRITICOS.md:483 , 2026-09-12, sem versão). A aplicação concreta segue a confirmar .
Escolha de interface	O portão nomeia a pergunta, e não o exame; o botão leva ao campo.

11 · Decisão humana

Decisão humana: ____ (nome, versão, data)

D-139 · Interpretação 3 · Julgamento individual pendente

Estado: aguardando decisão humana · **Criado em:** 2026-09-13 **Origem:** auditoria/DIVIDAS-CONHECIDAS.md:5768-5770 · decisão HR-4 em auditoria/PLANO-CORRECAO-AVC-CRITICOS.md:484

1 · Pergunta clínica

Quando a fonte manda ponderar caso a caso, o app deve segurar a liberação da trombólise até um julgamento registrado? Casos: DOAC nas últimas 48 h, mais de 10 microsangramentos e itens relativos da Table 8.

2 · População

Candidato à IVT com uma dessas condições registradas.

3 · Cenário

O portão chegou ao ponto de liberar, mas há uma situação "individualizada".

4 · Comportamento atual do código

o quê	onde
DOAC individualizado → exige_julgamento	avc/nucleo/derivacoes-d.ts:924
Microsangramentos (> 10) → exige_julgamento	avc/nucleo/derivacoes-d.ts:961
Item relativo com estado situacao_individualizada → exige_julgamento	avc/nucleo/derivacoes-d.ts:986
Portão → julgamento_individual_pendente, com liberado: false	avc/nucleo/portao-ivt.ts:499

- **Sem campo de "julgamento registrado":** a opção (b) da HR-4 ficou com o autor.
- **⚠ Achado por leitura, a verificar por execução:** quatro itens relativos com estado informacao_insuficiente não geram impedimento nenhum — malformação vascular não rota, dissecação intracraniana, neoplasia sistêmica ativa e punção arterial não compressível.
- **Cobertura:** nenhum teste liga microsangramentos > 10 ou itens relativos a julgamento_individual_pendente. Só DOAC é testado.

5 · Critério proposto — opções para decisão, sem escolha

opção	comportamento
A · atual	Julgamento pendente não bloqueia navegação, mas o portão não libera; não há gesto que registre o julgamento.
B	Um fato novo "julgamento individual registrado", com autor e hora, libera o portão.
C	Só DOAC exige julgamento; microsangramentos > 10 e itens relativos apenas informam.

6 · Exceções

Bloqueio de segurança, COR 3 e resultado pendente têm precedência sobre o julgamento (portao-ivt.ts).

7 · Dados necessários

- Horário da última dose do DOAC (existe; a janela de 48 h não é calculada, F-30).
- Carga de microsangramentos (existe como rótulo "> 10").
- Opção B: fato de julgamento com autor. Com a AC-40, o autor passa a ser a conta da sessão quando existe.

8 · Conduta diante de "não sei"

Hora do DOAC "não sei" → julgamento individual (derivacoes-d.ts). Microsangramentos desconhecidos → "baixa preocupação declarada", sem julgamento. A decisão deve cobrir os dois.

9 · Fonte primária

DOAC — AHA/ASA 2026, Table 8, faixa relativa, p. e365.

- **⚠ A tabela é imagem** no PDF; a frase foi conferida **só na transcrição** (aha-asa-2026-avc-isquemico.md:1759-1762, leitura visual).
- Trecho: "on an individual basis".

Microsangramentos — AHA/ASA 2026, §4.6.1 rec. 13 · COR 2b · LOE B-NR.

- Localização: PDF p. 39 = página impressa e354.
- Trecho literal (conferido no PDF): "a high burden (eg, >10) of CMBs".
- Transcrição: `aha-asa-2026-avc-isquemico.md:1096`, que diz que a utilidade da IVT é incerta.

Itens relativos — Table 8, faixa relativa, p. e364–e367.

- Imagem no PDF.
- Os verbos das células variam; resumo da transcrição em `:1010–1027`.

⚠ A fonte confirma só em parte.

- **DOAC:** a fonte confirma julgamento individual, sem contraindicação.
- **Microssangramentos > 10:** a fonte diz "utilidade incerta", não "base individual".
- **Itens relativos:** tratá-los como julgamento é interpretação.
- **Segurar ou liberar a ação:** a fonte não diz nada sobre isso.

10 · Separação das camadas

camada	conteúdo
Recomendação da diretriz	DOAC < 48 h: segurança desconhecida, considerar após análise individual de risco e benefício. Microssangramentos > 10: utilidade incerta (COR 2b). Faixa relativa: cautela moderada.
Adaptação local	Julgamento pendente não pode virar liberação automática. Decisão HR-4 do autor, 2026-09-12, sem versão. Não há campo novo nesta rodada.
Escolha de interface	Título "Situação que a fonte manda avaliar individualmente"; a decisão de prosseguir só aparece com o portão liberado.

10A · Atualização da 4ª rodada (2026-09-13)

- **AC-48 · reproduzido e corrigido** em `62856f4`: os quatro itens de "segurança desconhecida" passaram a aparecer como **informação**, sem reter. Reter ou pedir julgamento continua **sem decisão** (opções deste pacote).

11 · Decisão humana

Decisão humana: ____ (nome, versão, data)

D-139 · Interpretação 4 · Déficit incapacitante só na rota padrão

Estado: aguardando decisão humana · **Criado em:** 2026-09-13 **Origem:** auditoria/DIVIDAS-CONHECIDAS.md:5771-5773
· HR-2 em auditoria/PLANO-CORRECAO-AVC-CRITICOS.md:482

1 · Pergunta clínica

A trombólise em **janela estendida** exige déficit incapacitante, como a rota padrão?

2 · População

Candidato à IVT fora da janela padrão: início desconhecido com RM, despertar, 4,5–9 h, ou oclusão de grande vaso sem trombectomia.

3 · Cenário

Uma rota de janela estendida tem todos os seus critérios satisfeitos, e o déficit está registrado como "Não incapacitante", "Incerto" ou não perguntado.

4 · Comportamento atual do código

o quê	onde
Rota por início desconhecido: exige início desconhecido, DWI < 1/3, FLAIR sem alteração marcada e janela, sem déficit incapacitante	avc/conteudo/superficie-f.ts:638
Despertar / 4,5–9 h: sem déficit incapacitante; travada por F-31	avc/conteudo/superficie-f.ts:670
Oclusão de grande vaso sem trombectomia: sem déficit incapacitante; travada por F-31	avc/conteudo/superficie-f.ts:693
Rota padrão = elegibilidade clínica (inclui déficit incapacitante) e janela	avc/nucleo/veredito-da-trombolise.ts:514
Prova: início "não sei" + RM, sem registrar déficit incapacitante → "indicada"	scripts/prova-avc-criticos.cjs:662

- **Na prática** só a rota por início desconhecido sustenta sem déficit incapacitante; as outras duas estão travadas.
-  **Achado por leitura, a verificar por execução:**
 - Situação: déficit "Não incapacitante" com uma rota estendida aplicável.
 - Leitura: `rotaSustenta` fica verdadeiro, então o veredito pode sair "indicada".
 - Limite da COR 3 da rec. 8: só alcança quem tem "Leve" e "Não incapacitante" dentro de 4,5 h.
 - Nenhum teste cobre esse caso.

5 · Critério proposto — opções para decisão, sem escolha

opção	comportamento
A · atual	Déficit incapacitante só na rota padrão; rotas estendidas usam a população que a própria recomendação escreve.
B	Déficit incapacitante exigido em todas as rotas.
C	Opção A, mas "Não incapacitante" registrado impede também as rotas estendidas.

6 · Exceções

As rotas travadas por F-31 não sustentam enquanto a fonte estiver aberta.

7 · Dados necessários

Déficit incapacitante (`incapacitante_assumido`: "Incapacitante" / "Não incapacitante" / "Incerto"), já existente.

8 · Conduta diante de "não sei"

"Incerto" e não perguntado ficam como insumo ausente e só afetam a rota padrão. A decisão deve dizer se afetam as estendidas.

9 · Fonte primária

Rota padrão — AHA/ASA 2026, §4.6.1 rec. 1 · COR 1 · LOE A.

- Localização: PDF p. 38 = página impressa e353.
- Trecho literal (conferido no PDF): "*with disabling deficits, regardless of NIHSS score*".
- Transcrição: `aha-asa-2026-avc-isquemico.md:2348-2351`.

Janela estendida — AHA/ASA 2026, §4.6.3 rec. 1 · COR 2a · LOE B-R.

- Localização: PDF p. 44 = página impressa e359.
- Trecho literal (conferido no PDF): "*have unknown time of onset and are within 4.5 hours from symptom recognition*".
- Transcrição: `:289-295`. As recs. 2 e 3 estão em `:297-310`.

⚠ A fonte não trata disso.

- As recomendações de janela estendida **não** usam "disabling".
- Mas também **não** dizem que o critério fica de fora.
- A rec. 1 da §4.6.1 fala da rapidez do tratamento e pressupõe "eligible for IVT".

10 · Separação das camadas

camada	conteúdo
Recomendação da diretriz	Rota padrão com déficit incapacitante (§4.6.1). Rotas estendidas com populações próprias, sem menção a déficit incapacitante (§4.6.3).
Adaptação local	Leitura literal: o critério pertence à rota padrão. Registrada como "observação, não como decisão nova" na HR-2 (PLANO:482). A confirmação segue pendente (D-PEND-11).
Escolha de interface	Quando uma rota estendida sustenta, a lista de critérios troca o déficit e a janela pela recomendação estendida aplicável.

10A · Atualização da 4ª rodada (2026-09-13)

- **AC-47:** o cenário de perfusão pedido pelo autor **não reproduziu** (rota travada pela F-31; `nao_elegivel_a_evt` nunca satisfeito — AC-52).
- A rota de RM com início desconhecido **reproduziu** e foi corrigida em `62856f4`, no sentido pedido pelo autor: com o déficit **registrado** "não incapacitante", a saída é "Sem indicação neste caminho", com o motivo.
- "Incerto" e não perguntado não mudaram. Isso cobre em parte a opção C deste pacote; o resto continua **sem decisão**.

11 · Decisão humana

Decisão humana: ____ (nome, versão, data)

docs/avc/revisao/AC-03r-puerperio.md

Registro fora do pacote: a janela de 14 dias foi decidida pela D-PEND-24 (docs/decisoes.md, 2026-09-13), e o pacote não foi carimbado (docs/status.md, fila, linha 16). A §12 do pacote registra que a Table 8 de 2026 não confirma a janela.

AC-03 (resíduo) · Janela de puerpério

Estado: aguardando decisão humana · **Criado em:** 2026-09-13 **Origem:** docs/avc/auditoria-vs-spec.md:371 ("Puerpério sem duração") · requisito docs/avc/matriz-requisitos.md:140 (RQ-POP-01)

1 · Pergunta clínica

Até quanto tempo depois do parto uma paciente conta como "puérpera" para o portão de população, que retém protocolo e dose adultos?

2 · População

Mulher adulta com suspeita de AVC.

3 · Cenário

O médico responde à pergunta "Gestação ou puerpério" antes de qualquer regra adulta.

4 · Comportamento atual do código

o quê	onde
Opções: "Não gestante e não puérpera" / "Gestante" / "Puérpera" / "Não sei"	avc/conteudo/paciente.ts:79 e :104
"Puérpera" → fora do escopo validado, encaminhar	avc/nucleo/populacao.ts:48
"Não sei" → pergunta pendente; retém protocolo e dose	avc/nucleo/populacao.ts:56
Texto antigo com "primeiros 10 dias pós-parto": sem consumidor no AVC e sem fonte registrada	removido pela D-PEND-20 em f314f36

O app não define janela: "puérpera" é resposta binária do médico. Não há campo de data do parto nem de dias pós-parto.

5 · Critério proposto — opções para decisão, sem escolha

opção	comportamento
A · atual	"Puérpera" é juízo do médico, sem janela definida pelo app.
B	O app mostra junto da pergunta uma janela definida por decisão humana a partir de fonte identificada.
C	O app pergunta a data do parto e aplica a janela da opção B.

6 · Exceções

O portão vale para gestante e puérpera igualmente; a Estabilização continua aberta (decisão do autor de 2026-09-13).

7 · Dados necessários

- Opção B: a janela e a fonte dela (não localizada, ver §9).
- Opção C: data do parto.

8 · Conduta diante de "não sei"

Hoje "Não sei" mantém a pergunta, e a dose por peso não aparece. É escolha do autor de 2026-09-13, "igual à idade": protocols/fontes-verbatim/escopo-populacional-avc.md:29.

9 · Fonte primária

Escopo populacional (F-37), declarado pelo autor; não é fonte clínica.

- protocols/fontes-verbatim/escopo-populacional-avc.md:40–42 lista, entre o que o registro não sustenta, a "definição da duração do puerpério".
- :46: "A palavra puérpera é resposta do médico, sem critério do app."

AHA/ASA 2026, Table 8 Other Situations That May Arise in Thrombolysis Decision-Making, p. e364–e367 (PDF p. 49–52).

- A tabela é **imagem** no PDF, e a busca por `pregnan|postpartum|puerper|peripartum` no texto extraído retorna 0.
- A transcrição do repositório registra, em paráfrase e não em verbatim, que gestação e puerpério estão na faixa **relativa**, e declara a linha "Não transcrito como regra do V1" (`aha-asa-2026-avc-isquemico.md:1110-1132`).
- **A frase literal dessa linha não foi conferida nesta rodada.**

⚠ **Nenhuma fonte aberta define a duração do puerpério para este uso.** O texto antigo com "10 dias" não tem fonte registrada.

10 · Separação das camadas

camada	conteúdo
Recomendação da diretriz	Não conferida: a linha de gestação e puerpério da Table 8 é imagem e não foi transcrita literalmente.
Adaptação local	Gestante e puérpera ficam fora do escopo validado, com a conduta "encaminhar" (instrução escrita do autor, 2026-09-13, rodada AC-03).
Escolha de interface	Resposta binária do médico; "Não sei" mantém a pergunta.

11 · Decisão humana

Decisão humana: ____ (nome, versão, data)

12 · Table 8 conferida no PDF (18ª rodada, 2026-09-14)

- **Linha conferida:** AHA/ASA 2026 (versão online corrigida), Table 8, faixa relativa, p. e366, "Pregnancy and post-partum period". A trombólise pode ser considerada na gestação e no puerpério quando o benefício no AVC moderado ou grave supera o risco de sangramento uterino, com consulta obstétrica de emergência. **Não há janela em dias:** a linha está sem janela em dias.
- **Consequência para a D-PEND-24:** os 14 dias do app ("fonte AHA 2019, a confirmar na Table 8 de 2026") **não são confirmados** pela Table 8 de 2026, que não traz número.
- **Bula profissional Actilyse (I23-01), p. 4:** "parto nos últimos 10 dias" entre as contraindicações gerais por alto risco de hemorragia. É a fonte do texto "10 dias" removido pela D-PEND-20 por falta de fonte.
- **Três posições, sem decisão:** bula 10 dias (contraindicação) · AHA/ASA 2026 sem janela (faixa relativa) · app 14 dias (D-PEND-24, AHA 2019 não transcrita).
- **Pacote relacionado:** `docs/avc/revisao/bula-x-diretriz.md` §7.
- **Decisão humana:** ____

AC-13 · Estados da ação (4 × 8)

Estado: aguardando decisão humana · **Criado em:** 2026-09-13 **Origem:** docs/avc/auditoria-vs-spec.md:44 (AC-13) · requisito docs/avc/matriz-requisitos.md:67 (RQ-T06-01)

1 · Pergunta clínica

Que estados uma intervenção precisa registrar para que a trilha diga, sem ambiguidade, o que foi indicado, decidido, preparado, iniciado, concluído, interrompido ou cancelado?

2 · População

Toda intervenção registrada no módulo: ação corretiva da superfície Correções e trombólise.

3 · Cenário

O médico registra o que aconteceu com uma ação, inclusive fora da ordem, por exemplo registrando direto "realizada".

4 · Comportamento atual do código

o quê	onde
Tipo com 6 estados: <code>sugerida</code> , <code>disponivel</code> (derivados); <code>iniciada</code> , <code>realizada</code> , <code>interrompida</code> , <code>cancelada</code> (médico)	<code>avc/nucleo/tipos.ts:244</code>
Opções que a tela oferece: os 4 do médico	<code>avc/conteudo/superficie-e.ts:81</code>
Campo <code>acao_estado</code> , sem opção "Não sei"	<code>avc/conteudo/superficie-e.ts:197</code>
Trombólise usa o mesmo vocabulário	<code>avc/nucleo/derivacoes-f.ts:924</code>

Contagens de estados nos documentos:

documento	quantos	onde
PDF da spec v1.1	8: indicado, decidido, prescrito, preparado, iniciado, administrado/concluído, interrompido, cancelado	<code>docs/spec-avc.md:357</code>
Especificação interna §2.3, emenda de 2026-09-12	6	<code>auditoria/ESPECIFICACAO-AVC.md:884-918</code>
Código	4 registráveis	acima

5 · Critério proposto — opções para decisão, sem escolha

opção	comportamento
A · atual	4 estados registráveis (iniciada, realizada, interrompida, cancelada).
B	Os 8 estados da spec.
C	Os 4 atuais, mais parte dos 4 que faltam, escolhidos um a um (indicado, decidido, prescrito, preparado).

6 · Exceções

- Interrompida × cancelada:** a distinção já vigente não pode se perder. "Interrompida" significa que houve exposição; "cancelada" significa antes do início, sem exposição.
- Consumidores:** a exposição ao trombolítico é lida pelo histórico (`derivacoes-f.ts`, `exposicaoDaInstancia`).

7 · Dados necessários

- Horário de cada transição (a spec pede horários reais, quantidade, responsável e motivo da interrupção: `docs/spec-avc.md:358`).
- Opção B ou C: os novos estados e quem os registra.

8 · Conduta diante de "não sei"

Hoje `acao_estado` e `ivt_estado` **não** oferecem "Não sei". Um valor `nao_sei` gravado seria lido como ausente (`derivacoes-e.ts`). A decisão deve dizer se "não sei o que aconteceu com a ação" é registrável.

9 · Fonte primária

- **Nenhuma fonte clínica define estados de ação.** Busca por `discontinuu|interrupt|cancel|prescri|administered|state` na AHA/ASA 2026, nas bulas, no contrato da trombólise e nas definições operacionais: nenhuma lista de estados.
- **Única frase que toca o tema** — AHA/ASA 2026, **Table 7**, PDF p. 43 = e358, conferida no PDF:
 - Trecho literal: "*discontinue the infusion (if IV alteplase is being administered)*".
 - A frase sustenta que interromper uma infusão iniciada é evento real, isto é, distingue interrompida de cancelada.
 - Ela **não** define os demais estados.

A fonte não trata da questão. O número de estados é escolha de especificação e interface.

10 · Separação das camadas

camada	conteúdo
Recomendação da diretriz	Nenhuma sobre estados. A Table 7 prevê interromper a infusão diante de piora.
Adaptação local	Vocabulário de 4 estados fixado na decisão D2 (<code>auditoria/PLANO-CORRECAO-AVC-CRITICOS.md:44-46</code> , 2026-09-12). Não há registro humano que decida contra os 8 estados da spec.
Escolha de interface	Estados derivados (sugerida, disponível) não são registráveis; o médico pode registrar fora da sequência.

11 · Decisão humana

Decisão humana: ____ (nome, versão, data)

AC-14 · Temperatura no caminho isquêmico

Estado:  decidido (D-PEND-18) e implementado em `f314f36` · **Criado em:** 2026-09-13 **Origem:** docs/avc/auditoria-vs-spec.md:45 (AC-14) · requisito docs/avc/matriz-requisitos.md:29 (RQ-T01-03)

1 · Pergunta clínica

No AVC isquêmico, o app deve registrar a temperatura na chegada e sinalizar hipertermia?

2 · População

Adulto com AVC isquêmico em atendimento de emergência.

3 · Cenário

Observações de chegada da Estabilização: PA, FC, FR, SpO₂, glicemia, consciência e temperatura, segundo a spec (docs/spec-avc.md:262).

4 · Comportamento atual do código

o quê	onde
Campo de temperatura e eixo E removidos	commit <code>b170b44</code> (2026-09-12)
e2e fixa a ausência do campo	<code>e2e/avc-cockpit-abcde.spec.ts:235</code> (avc-num-caixa-temperatura com contagem 0)
Prova fixa quatro eixos, ABCD	<code>scripts/prova-avc-ameacas.cjs</code> (lista de letras "ABCD")
Só resta "Temperatura" como opção de monitorização , sem valor	<code>avc/conteudo/superficie-a.ts:396</code>
No ramo de hemorragia intracerebral, a recomendação de temperatura existe como cartão (H-06)	<code>avc/conteudo/hemorragia-intracerebral.ts:560</code>

Razões do commit `b170b44`:

- Frase do autor: *"exposição não precisamos no app AVC... é só mais um item para confundir"*.
- *"Se a fonte-mãe do isquêmico trouxer corte ou conduta, o eixo volta com ela e não por analogia."*

5 · Critério proposto — opções para decisão, sem escolha

opção	comportamento
A · atual	Sem campo de temperatura no isquêmico.
B	Campo de temperatura na chegada, só como observação (RQ-T01-03), sem regra.
C	Opção B, mais um aviso de hipertermia ligado à §4.4, com o corte definido por decisão humana a partir da fonte.

6 · Exceções

O ramo de hemorragia intracerebral já tem a recomendação própria (H-06), que não depende desta decisão.

7 · Dados necessários

- Temperatura com unidade, horário e origem (hoje não existe no isquêmico).
- Opção C: o corte, que a fonte só dá no texto de sinopse, não na recomendação (ver §9).

8 · Conduta diante de "não sei"

Hoje não há campo, então não há "não sei". Se o campo voltar, "não medida" não pode valer como normal (RQ-T01-03: "não medido ≠ normal; campo vazio fica vazio").

9 · Fonte primária

AHA/ASA 2026, §4.4 Temperature Management, PDF p. 37 = página impressa e352. Conferido no PDF.

recomendação	classe e nível	trecho literal
rec. 1	COR 1 · LOE B-R	"targeting normothermia, including using nurse-initiated protocols for managing fever, is recommended"
rec. 2	COR 1 · LOE C-EO	"sources of hyperthermia, such as infection, should be identified and treated"

recomendação	classe e nível	trecho literal
rec. 3	COR 3: No Benefit · LOE B-R	" <i>treatment with induced hypothermia or prophylactic fever prevention is not recommended</i> "

- **Sinopse** (texto de suporte, não recomendação): "*temperatures >37.5°C*".
- **Transcrição:** a §4.4 **não foi transcrita**. A busca por `temp|therm|fever` em `aha-asa-2026-avc-isquemico.md` retorna 0.

⚠ **A fonte não confirma o comportamento atual.**

- A fonte-mãe **tem** recomendações COR 1 sobre hipertermia no AVC isquêmico.
- A remoção foi feita porque "nenhuma fonte transcrita dá corte" (`auditoria-vs-spec.md:277`). A lacuna era da **transcrição**, não da diretriz.
- O corte numérico aparece só na sinopse.

10 · Separação das camadas

camada	conteúdo
Recomendação da diretriz	Tratar hipertermia buscando normotermia (COR 1); identificar e tratar a causa (COR 1); não induzir hipotermia nem prevenir febre de rotina em normotermia (COR 3).
Adaptação local	Remoção do eixo E e da temperatura (autor, 2026-09-12). Registro só na mensagem do commit <code>b170b44</code> ; não está em <code>docs/decisoes.md</code> .
Escolha de interface	A spec pede a temperatura entre as observações de chegada (RQ-T01-03), e o app não a tem.

11 · Achado registrado junto

- **AC-44 · alta · clínico.** O caminho isquêmico não registra temperatura, embora a fonte-mãe tenha recomendação COR 1 (§4.4).
- A remoção se apoiou na ausência de transcrição, não na ausência de fonte.
- **Não corrigido:** exige decisão clínica.

12 · Decisão humana

Decisão humana: restaurar a temperatura no caminho isquêmico, transcrevendo a §4.4 (p. e352) — Sandro Dainez, 4ª rodada, 13/09/2026 (`docs/decisoes.md` D-PEND-18).